Processo nº 0023883-02.2024.8.17.2001

AUTOR(A): ANA CAROLINA DOS SANTOS GALIZA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de **ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada** ajuizada por **ANA CAROLINA DOS SANTOS GALIZA** em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE** e **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A**.

A autora alega ser beneficiária de plano de saúde administrado pelas rés desde 30 de maio de 2022, conforme contrato de adesão firmado entre as partes. Informa que está na 7ª semana de gestação, sendo sua gravidez considerada de risco em razão de histórico clínico que inclui trombose venosa profunda (TVP), quatro abortos espontâneos anteriores, parto prematuro e câncer de mama, com diagnóstico médico enquadrado nos códigos CID-10 O68, N96, O22.3 e D68.3.

Diante da gravidade do quadro clínico, suas médicas assistentes – hematologista e ginecologista – prescreveram o uso diário do medicamento Clexane 40mg (enoxaparina sódica) como tratamento essencial para prevenção de eventos tromboembólicos e para preservação da gestação. Todavia, a autora relata que teve o fornecimento do medicamento negado pela operadora SulAmérica sob o argumento de que o procedimento solicitado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Sustenta a parte autora que a negativa é abusiva e injustificada, uma vez que o medicamento é registrado pela ANVISA, amplamente utilizado no tratamento prescrito e, inclusive, indicado por diretrizes técnicas da CONITEC. Alega ainda que a justificativa da ausência no rol da ANS não pode prevalecer, considerando o caráter exemplificativo desse rol, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta, também, que a conduta das rés viola os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde e à vida, especialmente considerando a condição de gestante em situação de risco.

Diante disso, requer, em sede de tutela de urgência, que a SulAmérica seja compelida a fornecer o medicamento Clexane 40mg, na forma prescrita, no prazo de 48 horas, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada, a condenação das rés ao fornecimento integral da medicação durante toda a gestação e até 40 dias após o parto, além da restituição dos valores já despendidos pela autora, no montante de R$ 2.177,38, a título de danos materiais. Pede, ainda, a declaração de nulidade de cláusulas abusivas do contrato firmado com as rés, a inversão do ônus da prova, o julgamento antecipado da lide e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Decisão de ID 163732497 indeferiu o pedido de tutela de urgência, entendendo ausente a probabilidade do direito da autora.

A parte autora atravessou nos autos a petição de ID 164899714, comunicando acerca da interposição do agravo de instrumento nº 0009650-52.2024.8.17.9000 e renovou o requerimento de apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

Analisando o pedido liminar a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco deferiu o pedido determinando o fornecimento do medicamento. Em posterior juízo de cognição exauriente, foi dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão hostilizada e ratificar os termos da liminar concedida.

Devidamente citado, o réu ofereceu contestação (ID 165902224) alegando, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a legalidade da negativa de fornecimento do medicamento Clexane 40mg, sustentando que o fármaco possui caráter experimental para a indicação pretendida pela autora (profilaxia de trombose em gestante com histórico de abortos). Alega que, segundo o contrato e o Rol de Procedimentos da ANS, tal tratamento não possui cobertura obrigatória, pois o medicamento não está incluído para essa finalidade específica. Destaca ainda que a operadora não nega tratamentos de cobertura obrigatória e que respeita os critérios técnicos estabelecidos pela legislação regulatória vigente, de modo que não se pode impor a ela o custeio de tratamento fora do escopo do plano contratado.

A empresa também sustenta a ausência de ato ilícito, pois apenas exerceu regularmente um direito contratual, o que afasta qualquer dever de indenizar. Defende a validade das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e a legalidade da recusa com base na ausência de previsão normativa e contratual, bem como na inexistência de comprovação científica suficiente quanto à eficácia do medicamento para o caso concreto. Ao final, requer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, inclusive o de tutela provisória, e pugna pelo indeferimento dos pedidos de danos materiais e pela manutenção do equilíbrio atuarial do contrato.

Em petitório de ID 171807066 a autora requereu a desistência da ação em relação a ré **QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A**., uma vez que até a referida ocasião a sua citação ainda não havia sido validamente realizada.

É o que importa relatar.

Decido.

Inicialmente, **homologo o pedido de desistência** em relação ao réu QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Consigno que o feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise e o convencimento judicial acerca da questão de mérito prescindem de dilação probatória, já que a documentação colacionada pelas partes autoriza o imediato enfrentamento.

Por oportuno, cumpre esclarecer que "*Não é necessário o anúncio prévio do julgamento do pedido nas situações do art. 355 do CPC*" (Enunciado n° 27 da I Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça).

Conforme relatado, o réu impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, a qual passo a analisar.

Em relação à **impugnação ao pedido de gratuidade de justiça**, sob o argumento de que a autora não comprovou sua hipossuficiência financeira, não merece prosperar.

O referido benefício é cabível mediante a afirmação de que a parte demandante não tem condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Além disso, o Código de Processo Civil prevê que o pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, o juiz determinar a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Ao analisar a condição de hipossuficiência da parte, o juízo leva em consideração a situação peculiar de cada caso, avaliando sempre o momento de hipossuficiência vivido pelo requerente, o qual poderá ser reavaliado a qualquer momento, sendo revogado quando e se houver mudança na situação econômico-financeira do beneficiário.

Ressalve-se que a gratuidade da justiça compreende, além das taxas e custas judiciais, outras demais despesas previstas no art. 98, §1º do CPC/2015, dentre elas: os selos postais; as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; a

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; os honorários do advogado e do perito; o custo com a memória de cálculo quando exigida para instauração da execução; os depósitos previstos em lei para interposição de recurso...

Na impugnação em análise, o impugnante não juntou aos autos qualquer prova suficiente para convencer este Juízo de que a beneficiário não se enquadra na condição preconizada por lei.

Pelo exposto, com fundamento no art. 98 do CPC/2015, **DEFIRO** o pedido de gratuidade de justiça à parte autora e julgo **IMPROCEDENTE** a impugnação**.**

Superadas as preliminares e questões processuais pendentes, registro ser desnecessária a produção de outras provas, inclusive a prova pericial, pois, além de representar atraso na marcha processual, o que eventualmente se comprovaria por meio de prova dessa natureza também pode ser obtido por intermédio de documentos, sendo eles suficientes para aferir se as irregularidades apontadas na exordial realmente ocorreram.

Registre-se ainda que a apresentação de réplica é desnecessária no caso em apreço, porquanto depreende-se ausência de matéria fática a ser discutida, sendo a matéria versada eminentemente de direito.

Pois bem.

O ponto controvertido da ação reside em perquirir se há obrigação de custeio, pelo plano réu, de medicamento que evita abortamento, trombose materna, pré-eclâmpsia, prematuridade e retardo do crescimento intrauterino, cujo nome comercial é Clexane.

A parte autora, alegando não possuir condições de arcar com o preço elevado do tratamento, pretende ver custeado pelo plano de saúde o fornecimento do medicamento. Entretanto, alega a parte ré que o mencionado fármaco é de uso domiciliar, não estando sua cobertura abrangida pelo contrato firmado entre as partes.

Pondero.

As operadoras de planos de saúde devem oferecer todos os subsídios necessários para o tratamento do paciente, incluídos os medicamentos, enquanto o beneficiário estiver em atendimento hospitalar assistido pelo plano contratado. Entretanto, quando o tratamento medicamentoso for administrado fora do ambiente hospitalar, ou seja, quando o medicamento for de uso domiciliar, os planos não têm a obrigação de custeio, com exceção de remédios antineoplásticos orais, que são utilizados para o controle dos efeitos adversos relacionados à quimioterapia.

A Agência Nacional de Saúde, órgão regulador responsável pela criação de normas, controle e fiscalização do setor de planos de saúde, traz a definição de medicamento de uso domiciliar, esclarecendo no artigo 13, parágrafo único, inciso VI, da resolução nº. 167:

> Art. 13. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
>
> Parágrafo único. São permitidas as exclusões assistenciais previstas no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 1998, observando-se as seguintes definições:
>
> (...)
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar: medicamentos para tratamento domiciliar **são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde** (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência); (grifos nossos)

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes possui expressa exclusão de cobertura para medicamento de tratamento domiciliar, tendo sido a cláusula restritiva redigida de forma clara de modo a não causar qualquer dúvida em sua interpretação. Tal restrição contratual encontra amparo na legislação especial, mais especificamente no artigo 10, VI, da lei nº. 9.656/98.

Ora, o remédio cujo custeio se pleiteia se trata de um anticoagulante de uso injetável domiciliar, por via subcutânea, de modo que já vem com a seringa preenchida, podendo a própria paciente se auto-aplicar, sendo desnecessária a internação hospitalar ou ambulatorial, bem como o acompanhamento por profissionais especializados. Tal hipótese se coaduna

perfeitamente com a exclusão de cobertura autorizada pela lei e prevista no contrato, não se podendo, portanto, reconhecer qualquer abusividade da cláusula contratual.

Nessa linha intelectiva, em que pese a 6ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0009650-52.2024.8.17.9000, ter analisado em sede de cognição sumária a questão da obrigatoriedade de custeio do medicamento em tela à luz da taxatividade ou não do rol da ANS, com as máximas vênias, destaca-se que o **Superior Tribunal de Justiça** possui entendimento consolidado de que a cobertura de medicamentos não antineoplásicos para uso domiciliar não é obrigatória em razão de expressa previsão legal. Vejamos:

> DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que manteve a condenação da operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento enoxaparina, para tratamento de trombofilia gestacional, além de indenização por danos materiais e morais.
>
> 2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o fornecimento do medicamento e fixando indenização por danos materiais e morais.
>
> A Corte estadual manteve a decisão, destacando a urgência do uso do medicamento, registrado na Anvisa, tendo em vista o risco de interrupção da gravidez e o histórico de abortamento da autora.
>
> II. Questão em discussão
>
> 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o fornecimento de medicamento de uso domiciliar por operadora de plano de saúde, considerando a exclusão prevista na legislação; e (ii) saber se houve omissão no acórdão recorrido quanto ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar.
>
> III. Razões de decidir
>
> 4. Inexiste ofensa aos arts. 490 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
>
> 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas como antineoplásicos orais e medicação assistida.

6. O medicamento enoxaparina, sendo de uso domiciliar e não se enquadrando nas exceções previstas, não deve ser coberto pelo plano de saúde.

7. A decisão do Tribunal de origem não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, devendo ser reformada para afastar o dever de cobertura do medicamento em questão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde do fornecimento do medicamento enoxaparina, julgando-se improcedente o pleito inicial.

Tese de julgamento: "1. É lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas previstas na legislação. 2. Medicamentos de uso domiciliar que não estão enquadrados nas exceções não devem ser cobertos por planos de saúde".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI;

CPC, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.165.682/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024.

(REsp n. 2.181.903/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, **julgado em 17/3/2025**, DJEN de 21/3/2025.)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e

ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.071.979/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, **julgado em 29/4/2024**, DJe de 2/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.635/MS, relator MinistroMarco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, **julgado em 18/12/2023**, DJe de 20/12/2023.)

Com efeito, consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei nº 9.656/98, o plano-referência não é obrigado a custear o "*fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12*", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care. Confira-se:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

> Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
>
> I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...)
>
> c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;
>
> II - quando incluir internação hospitalar: (...)
>
> g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Ainda, nos termos do artigo 13 da Resolução Normativa 465/2021, "caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas 'c', 'd', 'e' e 'g' do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998".

Trata-se de normativa estabelecida expressamente no artigo 17, parágrafo único, VI, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS:

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
>
> Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Não se pode perder de vista que a Constituição Federal autoriza à iniciativa privada prestar assistência à saúde, mas, preconiza, em seu artigo 196, ser a saúde um direito de todos e um dever do Estado.

Assim, a assistência ilimitada e irrestrita à saúde deverá ser prestada pelo Estado, cabendo à livre iniciativa proporcioná-la nos termos do pacto firmado entre os contratantes, desde que obedecidas as diretrizes legais e as administrativas que lhe são impostas pela agência reguladora do setor.

Imperioso esclarecer que a contratação de saúde suplementar não está completamente inserida no âmbito da autonomia da vontade, vez que o consumidor, ao firmar o contrato de assistência suplementar à saúde, o faz através de adesão. Porém, as operadoras tampouco possuem liberdade para elaborar o pacto na forma que lhes aprouver, pois estão adstritas às normas e regulações que lhes são impostas pelo Estado, através da Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão responsável pela promoção da defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. Note-se que, no presente caso, como dito, tanto a lei como a agência reguladora do setor expressamente autorizam as operadoras de plano de saúde a excluírem da sua cobertura o custeio de medicamentos de uso domiciliar.

É certo que o direito fundamental à defesa do consumidor possui um microssistema, o CDC, que reconhece a vulnerabilidade do consumidor, promovendo a proteção e defesa dos seus interesses. Entretanto, não se pode desconsiderar que no polo oposto da relação de consumo está um fornecedor de bens ou serviços também amparado pela proteção constitucional à livre iniciativa. Não é sem razão que o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 4º, III, estabelece a importância de "harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores".

Assim, não se pode, simplesmente, invocar a aplicação de um texto normativo vago e indeterminado, tal como aquele que estabelece ser nula a cláusula de contrato que coloca o consumidor em desvantagem exagerada (artigo 54, IV do CDC), para a afastar a aplicação de regra expressa, determinada e específica reguladora da matéria, que, harmonizando os princípios da dignidade da pessoa humana e da livre iniciativa, autorizou a

exclusão de cobertura pelos operadores de assistência à saúde suplementar dos medicamentos de uso domiciliar. Perceba-se que o ordenamento jurídico não deixa o cidadão desamparado da assistência à saúde, na medida em que prevê a obrigação de custeio da saúde de forma irrestrita pelo Estado. Ele apenas autoriza o agente econômico privado que atua no mercado de assistência à saúde a não efetuar o custeio de tais medicamentos, evitando o desestímulo da livre iniciativa em investir no setor de saúde suplementar, tão importante para a coletividade de consumidores. Registre-se que o desenvolvimento integral da pessoa humana não se dá apenas em seu aspecto pessoal, mas também dentro do equilíbrio de uma existência coletiva.

Este juízo é sensível à alegação de impossibilidade de custeio do medicamento pela parte demandante, devido ao seu alto custo durante todo o período de tratamento. Entretanto, a fundamentação de decisões na esfera judicial não pode se pautar apenas em argumentos morais ou afetivos, mas deve antes buscar a aplicação de uma adequada racionalidade jurídica.

No tocante ao fornecimento de medicação de uso domiciliar, o juiz Cristiano de Castro Jarreta Coelho, da comarca de São Paulo, em caso análogo (processo nº. 1031204-73.2017.8.26.0576) ponderou que "*não se pode adotar posição abrangente a ponto de autorizar todo e qualquer tratamento, sem qualquer avaliação, mesmo que não contratado, partindo-se da premissa humanitária de saúde, sob o rico de ocasionar falência do sistema, o que inviabilizará o tratamento dos demais segurados que efetivamente contribuíram para o quanto necessita. As seguradoras de saúde não podem substituir o Estado e, embora seja um direito constitucionalmente previsto o planejamento familiar e a constituição de família, de outro lado deve-se também considerar que esse dever é do Estado e não de empresa particular, a menos que tal procedimento assim fosse imposto como obrigatório por agência governamental ou expressamente previsto no contrato firmado. Vale lembrar que cada qual paga o plano que contrata, de acordo com as coberturas que anui, não havendo contratação específica para aquele exame ou procedimento, não se pode obrigar o plano a arcar com o que não recebeu. Permitir que uma medicação que não esteja vinculada a procedimento médico, ainda que tenha lamentável custo elevado, seja imputada como de obrigação do plano de saúde é mesmo que reconhecer*

que os planos têm de custodiar, além dos serviços médicos, toda e qualquer medicação, já que não haveria espaço ontológico para se diferenciar o fornecimento do quanto pretendido aqui e um antibiótico indicado para uma simples infecção. E isso significaria, por certo, ou a necessidade de reavaliação do programa contratual de todos segurados ou até mesmo a própria inviabilização da atividade do plano."

Por fim, pondero que a evolução técnica da medicina permitiu que alguns medicamentos tipicamente de uso em regime de internação hospitalar pudessem ser administrados no domicílio do paciente. Tais avanços trazem consigo uma grande vantagem àqueles que se veem obrigados a fazer uso destes medicamentos para sua convalescença, sobretudo aos pacientes que os utilizam de forma contínua, como é o caso das gestantes, pois lhes permitem permanecer fora do ambiente hospitalar e prescindirem do auxílio de profissionais para a administração assistida do fármaco durante toda a gestação. Contudo, permitem também, diante da facilidade de administração, a exclusão do custeio pelas operadoras de plano de saúde, vez que já não subsistem as condições legais e administrativas que lhes obrigam ao referido custeio.

Assim, considerando que medicamento de uso domiciliar pleiteado (Clexane) não se enquadra como antineoplásco oral, nem como medicação assistida (home care), entendo não haver qualquer abusividade nas cláusulas do contrato firmado entre as partes contratantes e reconheço a inexistência do dever de fornecimento pela operadora ré do medicamento pleiteado pela demandante, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% sobre o valor da causa (85, §2°, do CPC), restando suspensa, no entanto, a sua exigibilidade, tendo em vista ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.

Considerando a homologação de desistência da ação em relação ao réu QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, promova a Diretoria Cível a sua respectiva exclusão destes autos.

Caso seja interposto recurso de apelação, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Ficam as partes advertidas que o manejo de embargos de declaração reconhecidos manifestamente protelatórios, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Recife, 07 de agosto de 2025.

Júlio Cezar Santos da Silva

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: JULIO CEZAR SANTOS DA SILVA
07/08/2025 14:09:09
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 212235295

25080714090898300000206632910

IMPRIMIR GERAR PDF